

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent for Cholangiogram (Percutaneous) &/or Biliary Drain/Stent

إقرار الموافقة على تصوير القنوات المرارية عن طريق الجلد مع/أو التصريف المراري/وضع دعامة

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required?

☐ Yes ☐ No

If Yes, is an interpreter present?

☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The following will be performed. (Doctor/doctor delegate to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

A cholangiogram is an x-ray procedure that looks at your gall bladder and bile ducts. It is done by placing a needle into your bile duct, injecting Iodinated Contrast Media (once called x-ray dye) and taking x-ray pictures.

Depending on your condition you may also require a biliary stent or drain to be inserted.

A biliary stent is used instead of surgery to deal with a narrowed or blocked bile duct. A biliary stent is an internal drainage tube placed in your bile duct to stop or to temporarily relieve an obstruction causing the blockage.

A biliary drain is a small flexible tube (catheter) that is inserted through your skin and into the bile ducts to drain away your bile.

The insertion of a biliary drain and/or a stent is done as an extra step to the cholangiogram procedure. This procedure will require an injection of local anesthetic and sedation or a general anesthetic.

C. Risks of this procedure

In recommending a Cholangiogram &/or Biliary Drain/Stent, the doctor believes the benefits to you from having this procedure exceed the risks involved.

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following:

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising may occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- The catheter may become kinked or blocked. Sometimes it needs to be moved or replaced.
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة
إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يتوفر مترجم مؤهل؟
☐ نعم ☐ لا
☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة المرضية والعلاج

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

تصوير القنوات المرارية هو إجراء يتم بالأشعة السينية للكشف على الحويصلة المرارية (المرارة) والقنوات المرارية. يتم الإجراء عبر وضع إبرة في القناة المرارية، حقن مادة وسط متباين (تسمى سابقاً صبغة الأشعة السينية) وأخذ صور بالأشعة السينية.

وبناء على حالتك المرضية، فقد يتم أيضاً وضع دعامة مرارية أو أنبوب تجفيف (تصريف). الدعامة المرارية تستخدم كبديل للجراحة لعلاج تضيق أو انسداد القناة المرارية. هي عبارة عن أنبوب تصريف داخلي يوضع في القناة المرارية لإيقاف أو العلاج المؤقت للانسداد المسبب لانغلاق القناة المرارية.

أنبوب التجفيف المراري هو عبارة عن قسطرة صغيرة ومرنة توضع في القنوات المرارية عن طريق الجلد لسحب وتصريف مادة الكبد الصفراء.

إدخال أنبوب التجفيف (التصريف) و/أو الدعامة المرارية يعتبر خطوة إضافية بجانب تصوير القنوات المرارية.

يتطلب الإجراء حقنة من مخدر موضعي مع استخدام دواء مسكن أو تخدير كلي.

ج. مخاطر الإجراء

لقد أوصى طبيبك بتصوير القنوات المرارية عن طريق الجلد و/أو التجفيف المراري/الدعامة المرارية ويرى أن فوائد هذا الإجراء بالنسبة لك تتفوق على مخاطره.
مخاطر ومضاعفات هذا الإجراء تشمل، ولكنها غير محصورة في:

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل:

- ألم بسيط، كدمة و/أو عدوى بسبب إدخال الخط الوريدي. قد تتطلب معالجة بالمضادات الحيوية.
- ألم وشعور بعدم الراحة في موضع دخول إبرة العينة. قد يتطلب ذلك أدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة. وهو أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دابابير دامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث التواء أو انسداد للقسطرة وقد تكون هناك حاجة لإزالتها أو استبدالها.
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى أو استخدام طريقة تخدير أخرى.
- ضرر لعصب. غالباً ما يكون مؤقتاً ومن المفترض تحسنه مع الوقت. من

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Nerve damage is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.
- The stent/drain may move or become blocked. It may need to be replaced or removed.
- Pain, this may require medication.

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- Excessive bleeding. This may require other procedures and/or corrective surgery.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- Bile leak, this may require further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Skin burns or damage from exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

If sedation is given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around
- Fall in blood pressure
- Nausea and vomiting
- Weakness
- An existing medical condition getting worse
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. This may require emergency treatment
- Stroke resulting in brain damage.

D. Patient Consent

I acknowledge that the doctor/doctor delegate has explained the proposed procedure.

I understand:

- The risks and complications, including the risks that are specific to me.
- The sedation/anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor/doctor delegate or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor/doctor delegate undergoing further training may conduct this procedure.

- النادر حدوث ضرر دائم للعصب.
- قد تتحرك الدعامة/أنبوب التصريف من موقعها أو قد تنسد. قد تكون هناك حاجة لإزالتها أو استبدالها.
- الشعور بالألم. قد يتطلب ذلك أدوية.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- ضرر الأنسجة المجاورة كالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات. يتطلب معالجات أخرى.
- نزيف مفرط من موضع دخول الإبرة . قد يتطلب ذلك علاج آخر وأو جراحة تصحيحية.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء تتطلب علاجات أخرى.
- تسرب المادة الصفراء مما قد يتطلب معالجة أخرى.
- قد لا يمكن القيام بالإجراء لأسباب طبية وأو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- حروق أو ضرر للجلد بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و \ أو سكتة قلبية بسبب سمية المخدر الموضعي.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً.

مخاطر إضافية عند استخدام الدواء المسكن:

- إغماء أو دوخة ، خاصة عند بدء الحركة بعد الانتهاء من الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم.
- غثيان وقيئ.
- ضعف عام.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى.
- مشاكل في القلب والرئتين كالأزمة القلبية أو دخول المادة المتبقية إلى الرئة مسببة التهاب رئوي مما قد يتطلب تدخل طبي طارئ.
- سكتة دماغية تتسبب في ضرر للمخ.

د. إقرار المريض

أقر بأن الطبيب/ من ينوب عن الطبيب قد شرح لي الإجراء المقترح :
إنني على علم بما يلي :

- المخاطر والمضاعفات بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير \ الدواء المسكن المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي
- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

I have been given the following Patient Information Sheet:

☐ **Cholangiogram (Percutaneous) &/or Biliary Drain/Stent**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.
- I understand that International Medical Center may release my relevant de-identified information obtained from this and related procedures for education and training of health professionals.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

E. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (D) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ **تصوير القنوات المرارية عن طريق الجلد أو التجفيف المراري/الدعامة المرارية**

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيع لي هذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

- أن المركز الطبي الدولي قد يستخدم المعلومات الطبية المتحصلة من حالتي المرضية وفحوصاتي الطبية لأغراض التعليم والتدريب الطبي للممارسين الصحيين ، وذلك دون الكشف عن هويتي.

وبناء على ما تقدم، فإنني أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

هـ. بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (د) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____